

إسم المريض رابعياً : ساميه رمزى بطرس منصور

رقم البطاقة : 26702060102522 رقم التليفون : 01149944901 تاريخ تسجيل الإستمارة : 24-09-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 06-02-1967 المهنة : بدون عمل

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (-----) التوقيع: (-----)

المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضى الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونيك [14157]

التعليق على التشخيص: -----

الاسم: د/محمد كيلاني
 الاسم: د/ندى حسن
 الاسم: د/نرمين رمضان
 الوظيفة: _____
 الوظيفة: _____
 الوظيفة: _____
 التوقيع: _____
 التوقيع: _____
 التوقيع: _____
 تعتمد صحة البيانات الخاصة بالمجالس
 وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
 كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
 رئيس اللجنة ومدير
 المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

----- / 2 ----- / 2 ----- / 2.1 ----- / 2.1

التشخيص النهائي :
 خطة العلاج :
 المستشفى : قسم :
 جهة العلاج : نفقات :
 ملاحظات :

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: ساميه رمزي بطرس منصور National ID: 26702060102522	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

سامية
رمزى بطرس منصور
١٤ ش خالد بن الوليد - مهنين فيصل
الهرم - الجيزة

١٩٦٧/٠٢/٢٦ ٢٦٧.٢.٦.١.٢٥٢٢
JJ7880395

٢٠٢٢/٠٦ ٢٦٧.٢.٦.١.٢٥٢٢

ربة منزل
أنثى
مسيحية
ارملة

٢٠٢٩/٠٦/٠٢ البطاقة سارية حتى ١



ImmunohistoChemistry report

Report Number: m6115

Female	نوع	اسم المريض	53 Y
القاهرة	العنوان	السن	
24/10/2019 10:44	تاريخ استلام العينة	تاريخ اخذ العينة	
24/11/2019 10:25	تاريخ تسليم العينة	مركز أورام دار السلام	
		مركز أورام دار السلام	عناية

Primary Sample :

Paraffin Block

Test :

ER & PR & HER2 neu (ER&PR : Harvey scoring system - Her2neu : CAP scoring system)

Comment :

Technique :

sample recieved was treated by : - CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody.- CONFIRM anti-progesterone receptor(PR) (IE2)Rabbit monoclonal primary antibody.

Sample recieved was treated by : - VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody using DAB Detection kit in ventana benchmark GX.

Result :

ER: moderate nuclear staining of 70 % of tumour cells

PR: moderate nuclear staining of 70 % of tumour cells

HER2/neu protein over expression : strong continuous membrane staining of > 10 % of tumor cells

Referral Lab :

Comment :

Conclusion :

ER: POSITIVE (SCORE 7 / 8)

PR: POSITIVE (SCORE 7 / 8)

HER2/NEU PROTEIN OVER EXPRESSION : POSITIVE (SCORE 3 +) (CORE BIOPSY)

Pathologist:

د/إيناس رمزي

Lab Director:

د/ تريزا ماهر



Name: Samia Ramzy botros

Date: 8-2-2022

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

**** known case of breast cancer.**

1. Chest:

- Post right mastectomy status showing operative bed nodular cutaneous thickening.
- No sizable pulmonary masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- Right upper and middle lobar, anterior subpleural reticulo-nodular densities, representing post-radiotherapy changes.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion.
- Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is mildly enlarged with homogenous low CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- Calculus gall bladder. No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes. Left renal, Dromedary hump is noted.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Enlarged uterus with lobulated outline (? fibroids)
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy or collections.
- Dorso-lumbar spondylotic changes.
- Right iliac, small sclerotic osseous lesion is seen measuring 7 mm likely bone island.

OPINION:

- **No pulmonary or hepatic metastatic deposits.**
- **Calculus gall bladder**

Dr. Peter Nashaat, MSc

Dr. Amr Farouk MD

NAME: Samia Ramzy Betrous

Date: Sunday, August 30, 2020

Referred By : Prof. Dr.

REAL TIME ABDOMINAL AND PELVISULTRASOUND REVEALED:

- Liver is of enlarged size 17 cm , normal outline, normal echo pattern, no focal lesions , no Intra or extra hepatic biliary dilatation .
- The portal vein is seen of normal caliber
- The gall bladder shows no selective tenderness, average distended with normal wall thickness, no stones, polyps or biliary mud seen. CBD is not dilated.
- The spleen is normal size 11 cm in its long axis with normal echogenic pattern & no focal lesions.
- Both kidneys are of normal size, normal shape, normal site, normal parenchymal thickness, and no masses.
- The visualized part of the pancreas is sonographically free.
- The Aorta And IVC Of Normal sonographic appearance with no evidence of aortic dissection or aneurism
- Midline structures are concealed by gases.
- No intraabdominal fluid.
- The urinary bladder nearly empty at time of scan.
- The uterus is AVF, showing normal size and shape. Homogenous myometrium with two anterior wall focal lesions measuring 3.5 x 3.5 cm, isoechoic, and 2.8 x 3.7 hypoechoic.
- Both adnexae and both ovaries are free.
- No free fluid in cul de sac.

Opinion:

- Mild hepatomegaly, for clinical and laboratory correlation.
- Anterior uterine wall interstitial fibroids.
- Colonic distension.

Best regards

Dr. Mohamed Nour El Dein, FEBR.

8/30/2020 11:58:13 AM

MDT FORM

4 / 11 / 2025 G

Name	سامية عزى لطفى	MRN	C772/C.19
Age	57yo	ID	01221502404
Menopausal status	Post menop-	Phone	01283609720
NRS SCORE		Marital status	
BMI		Family history	
CO morbidity	- free	REASON OF MDT	New Clo.
- Rt MRM 3/2020 (Received Chemo/Radio-)			

Still on hormonal tx Clinical Data

BX:

ER:

PR:

HER 2:

Ki67:

Sonomammography:

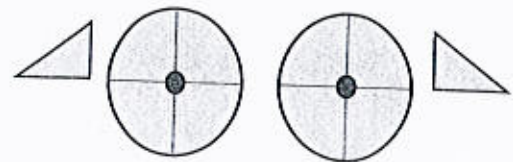
[PA ULS]

G.B polyp 10mm & 6mm

Mets Workup:

R

L



TNM

Recommendations:

for possibility of lap. Chole.
Tumor

MDT OUTCOME & PLAN

For lap. Cholecystectomy

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

SURGERY

RADIOLOGY

PATHOLOGY

Nutrition

Psychiatric

[Signature]

Dr. Hossam

18/11/2025

[Signature]

Patient Name: Samia Ramzi Botros Mansour	Date : 30/10/2025
Exam : ultrasound ABDOMEN& PELVIS	Age : 58 Year(s)
Medical ID: 2674/2019	Pat. ID: 22509

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION**Liver: -**

- Enlarged in size (17.5cm at Rt MCL) bright parenchymal echo pattern with smooth surface.
- No hepatic focal lesions or intra hepatic biliary radicle dilatation.
- Portal vein is patent and not dilated.

Gall Bladder: -

- Average distention and capacity with adherent stone/calcified polyp measuring 10mm & other smaller one 6mm
- CBD is not dilated.

Spleen: -

Average size, homogenous.

Kidneys: -

- Both are average in size, shape and echogenicity
- No stones or dilated pelvicalyceal system
- No gross lesion

Para-aortic and pancreatic area: show no gross abnormalities.

No ascites**Urinary Bladder: -**

- Average capacity with no stones or diverticular out pouching

Uterus and adnexa: uterus is bulky for age with multiple fibroids, the largest is subserous projecting from right lateral wall measuring 30x25mm

Opinion:

Fatty hepatomegaly, for laboratory correlation
Gall bladder adherent stone/calcified polyp
Fibroid uterus
Colonic gaseous distention

Signature Dr . Nermien Ramadan
PM 2:54 2025/10/30

Patient Name	سامية رمزي بطرس	Age	57
Sex	F	Special habits	
Family History		Comorbidity	
Surgical History	Rt MRM 3/2020 & received chemo/radio, still on hormonal ttt	Telephone	0122150244 01283609720
Menopausal Status	post	Marital Status	
ID	26702060102522	Medical ID	2674/2019
Date	18/11/2025	Reason of MDT	New C/O

Medical Report

Pathology:

T N M

PAUS: GB polyp 10mm & 6mm

Metsworkup:

Doctors' notes:

Recommendations : For possibility of lap. Chole

MDT DECISION

For lap. Cholecystectomy]

Name	د/ خالد عبدالعزيز	د/ هاشم عبدالرحمن	د/ ابو بكر حجازي
Signature	